جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سلوي محمد حسين =
المحافظة : الاسكندريه **الحي / المدينة :** الرمل **العنوان :** ++++
رقم البطاقة : 26503152602383 **رقم التليفون :** 01021882992 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-03-1965 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سلوي محمد حسين =
National ID: 26503152602383

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

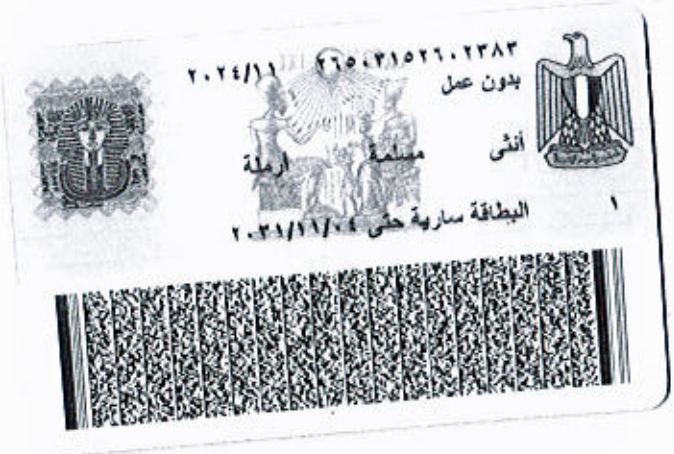
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bilateral mammogram and breast ultrasound**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة

Pathology Report

Name: سلوى محمد حسين **Age:** 57 years.

Clinical data: Left breast cancer.

Specimen type: Tru cut biopsy.

Date (Received):21 /6/2021. **Date(reported): 4/7/2021**

Lab. Number: 1303/ 21 **Hospital Number:** مبادره

Gross Examination:

- Procedure: tru cut
- Localization: Lt

Immunohistochemistry technique: Sections prepared from paraffin blocks for immune-staining using Bench-Mark ULTRA system for ER, PR, Her-2 and Ki67
ER clone (1E2). PR clone (SP1). Her-2 clone (4B5). & Anti-K-67 (30-9)

Microscopic examination:

- Histological type: IDC
- Grade II

Diagnosis:

Lt breast mass, tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma GII

- Biomarkers:
  - ER: negative (Allred score 0/8)
  - PR: faint Intensity 30% nuclear reaction (Allred score 4/8)
  - Her2: strong Intensity 10% complete membrane reaction (score 3+)
  - Ki67: 50 % nuclear reaction

Prof. Gamal AbdelAty
Dr. Rana Fathy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name : Salwa Mohamed El-Hussieny

Date : 19/09/2021

MRI EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE

Technique of examination:

- Sagittal T1 & T2 WIs "Plate 1 & 2".
- Axial GR/T2 WIs "Plate 3".
- No contrast was given.

A known case of breast cancer

MRI Findings:

- Straightened cervical curvature.
- Normal dimensions of the bony cervical spinal canal.
- Advanced spondylodegenerative changes of the cervical vertebrae in terms of:
  - Anteromarginal osteophytosis of the cervical opposing end plates more exuberant at C4-5, C5-6 and C6-7 levels.
  - Reduced hydration of all cervical discs.
- A small focal well-defined extra-medullary dural based intra-spinal lesion of altered marrow signals is seen elicit iso signals in T1, low T2 and high FLAIR signals. The lesion is measuring about 11x10 mm in its AP and Ts diameters respectively. it cause mass effect in the form of compression on the spinal cord with no associated cord malacia .
- C5-6 and C6-7 broad based posterior protrusions/osteophyte complex are seen obliterating the subarachnoid space, indenting the cord and encroaching on the related exit neural foramina.
- Normal MRI appearance of the cervical spinal cord and the cranio-cervical junction with no evidence of cord malacia or edema
- A small pontine syrinx formation is detected
- Normal marrow signal of the imaged vertebrae.
- No paraspinal signal abnormalities.

Conclusion:

- ***Advanced cervical spondylotic changes with C4-5 and C5-6 level posterior protrusions.***
- ***A small well-defined extra-medullary dural based intra-spinal lesion as above described. the possibility of intraspinal meningioma rather than metastatic deposit should be considered. Further correlation with the clinical data, laboratory testing & contrast enhanced MRI is highly justified .***

Dr. Alaa R. Hani, M.Sc

Dr. M. Gomaa, MD

[[DOCTYPE:MRI]]

Patient Name	: الأستاذه / سلوى محمد حسين	Request No.	: 13009825
Patient No.	: 26503152602383	Request Date	: 10/03/2022
Path No.	: 670/22	Verification Date	: 28/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast cancer. Post chemotherapy.

Nature of the specimen:
Left MRM.

Gross Examination:
• Procedure: Left MRM specimen measured 29x20x7cm, covering skin piece measured 25x22cm. Nipple . areola and skin were unremarkable grossly.
• Tumor extent: A rubbery greyish white tumour bed site.
o Size: 3x2.5x2cm.
• Localization: LOQ
• Distance from margins: 2cm away from deep margin and 4cm away from the skin.
• Lymph nodes number and size: 7 lymph nodes, up to 1.5x1cm.

Microscopic examination:
• Sections examined revealed no remnants of tumour tissue.
• Lymph node involvement: All lymph nodes were free (0/7).
• Resection Margins: Free deep margin.
• Free nipple and areola.
• Histologic response to therapy: Pathological complete response.
• Additional pathologic findings: No

Diagnosis:
Left MRM:
- No remnants of tumour tissue.
- Free deep margin, nipple and areola.
- All lymph nodes were free (0/7).

Verified by :
abdelrahman ibrahim

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (957) - كورنيش النيل - ميت القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 957- Nile Corniche - Mit El Qadema- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / سلوى محمد حسين	Request No.	: 13009825
Patient No.	: 26503152602383	Request Date	: 10/03/2022
Path No.	: 670/22	Verification Date	: 28/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

- Pathological complete response.
- Stage: ypT0, ypN0

Prof. Dr. Gamal Abd-El Atay
Dr. Abdulrahman Ibrahim

Verified by :
abdelrahman ibrahim

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (287) – المنيل قبل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 287- Nile Corniche - Misr El Qadima- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]